

TEMA 3.15 • OBSTETRICIA

Embarazo Ectópico — Definición y Diagnóstico

PERFIL EUNACOM 2.01.2.011  
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

# Embarazo Ectópico — Definición y Diagnóstico

Definición

Implantación del embarazo **fuera del útero**. 98% son tubarios. Otras localizaciones: ovárico, cervical, intraabdominal.

Factores de Riesgo

| TABLA 3.15.1: FACTOR DE RIESGO VS DETALLE |                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FACTOR DE RIESGO                          | DETALLE                                                                                                   |
| PIP previo (salpingitis)                  | Principal FR — daño tubario                                                                               |
| Ectópico previo                           | Daño residual de la trompa                                                                                |
| Cirugía tubaria (recanalización, etc.)    | Altera anatomía tubaria                                                                                   |
| ITS previas / promiscuidad                | FR indirecto de PIP                                                                                       |
| DIU o ligadura de trompas                 | Disminuyen el riesgo global de embarazo, pero si ocurre, el riesgo de que sea ectópico es <b>muy alto</b> |

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Una paciente con DIU o ligadura de trompas que llega con metrorragia y shock: **pensar en ectópico** — no descartar por el método anticonceptivo.

Clínica

| TABLA 3.15.2: ESTADO VS PRESENTACIÓN |                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                               | PRESENTACIÓN                                                                                               |
| No roto                              | Asintomático — hallazgo ecográfico                                                                         |
| Roto                                 | Metrorragia + dolor + <b>compromiso hemodinámico</b> (shock hipovolémico); puede haber signos peritoneales |

Diagnóstico

Base:  $\beta$ HCG (+) + ecografía transvaginal sin embarazo intrauterino

Diagnóstico de sospecha (cualquiera)

- Clínica de ectópico roto + factores de riesgo
- Líquido libre en cavidad peritoneal (sangre) en eco
- Masa anexial compleja (no compatible con cuerpo lúteo)
- $\beta$ HCG sobre el punto de corte sin visualización de embarazo intrauterino
- $\beta$ HCG que no sube adecuadamente en 48h (< 66% de incremento)

Diagnóstico confirmado (cualquiera)

- Ecografía visualiza el saco vitelino / embrión en la trompa
- Confirmación histológica post-cirugía
- Legrado sin restos ovulares + reacción de Arias-Stella (decidualización sin embarazo intrauterino)

Punto de corte de  $\beta$ HCG

| TABLA 3.15.3: BHCG VS INTERPRETACIÓN |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| BHCG                                 | INTERPRETACIÓN                                                                 |
| $\geq 3.500$ UI/L                    | Debería verse el saco intrauterino → su ausencia confirma sospecha de ectópico |
| 1.500–3.500 UI/L                     | Alta probabilidad de ectópico, pero persiste incertidumbre                     |
| < 1.500 UI/L                         | Puede ser embarazo normal de baja EG → controlar en 48h                        |

Evolución de  $\beta$ HCG en 48 horas

| TABLA 3.15.4: SUBIDA EN 48H VS INTERPRETACIÓN |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| SUBIDA EN 48H                                 | INTERPRETACIÓN                          |
| $\geq 66\%$                                   | Embarazo intrauterino normal            |
| < 66%                                         | Sospecha de ectópico (va a tratamiento) |
| Baja                                          | Ectópico o aborto completo              |

Embarazo Heterotópico

Embarazo gemelar: uno intrauterino + uno tubario. **No descartar ectópico por ver embarazo intrauterino** si la clínica es concordante. Manejo: cirugía del ectópico + preservación del intrauterino.

Conducta según Hemodinamia

| TABLA 3.15.5: ESTADO VS CONDUCTA |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ESTADO                           | CONDUCTA                                               |
| Hemodinamia inestable            | Diagnóstico de sospecha basta → <b>cirugía urgente</b> |

| **Hemodinamia estable** | Al menos 2 controles de  $\beta$ HCG + 2 eco TV cada 48h → decide MTX o laparoscopia |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 28 años con amenorrea de 7 semanas, beta-HCG de 2,500 mUI/mL, dolor en fosa ilíaca derecha y sangrado vaginal escaso. Ecografía TV: cavidad uterina vacía, imagen anexial derecha de 2.5 cm. ¿Conducta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Embarazo Ectópico — Definición y Diagnóstico. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Definición
- Factores de Riesgo
- Clínica
- Diagnóstico
- Diagnóstico de sospecha (cualquiera)
- Diagnóstico confirmado (cualquiera)
- Punto de corte de  $\beta$ HCG

## EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (EMBARAZO ECTÓPICO — DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO)

## PREGUNTA 1

Mujer de 28 años con amenorrea de 7 semanas, beta-HCG de 2,500 mUI/mL, dolor en fosa ilíaca derecha y sangrado vaginal escaso. Ecografía TV: cavidad uterina vacía, imagen anexial derecha de 2.5 cm. ¿Conducta?

- A)** Legrado uterino por aborto incompleto
- B)** Metotrexato intramuscular — paciente hemodinámicamente estable con criterios
- C)** Esperar evolución espontánea (expectante)
- D)** Laparotomía de urgencia
- E)** Repetir beta-HCG en 48h y si dobla, hospitalizar

## PREGUNTA 2

Mujer de 25 años con embarazo ectópico. Llega con PA 70/40 mmHg, FC 130 lpm, abdomen en tabla y dolor generalizado. ¿Conducta inmediata?

- A)** Metotrexato IM y observación 24h
- B)** Beta-HCG urgente para confirmar el diagnóstico
- C)** Laparoscopia/laparotomía de urgencia con reanimación simultánea
- D)** Transfusión de 2 unidades de GR y observar respuesta
- E)** Ecografía TV para confirmar localización antes de operar

## PREGUNTA 3

¿Cuál es el factor de riesgo más importante para embarazo ectópico?

- A)** Multiparidad
- B)** Antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) o cirugía tubárica previa
- C)** Uso de anticonceptivos orales combinados
- D)** Nuliparidad
- E)** Síndrome de ovario poliquístico

## RESUMEN: EMBARAZO ECTÓPICO — DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO

Implantación del embarazo fuera del útero. 98% son tubarios. Otras localizaciones: ovárico, cervical, intraabdominal. ::warning Una paciente con DIU o ligadura de trompas que llega con metrorragia y shock: pensar en ectópico — no descartar por el método anticonceptivo. ::: Embarazo gemelar: uno intrauterino + uno tubario. No descartar ectópico por ver embarazo intrauterino si la clínica es concordante. Manejo: cirugía del ectópico + preservación del intrauterino.